

TEMA 3.10 • OBSTETRICIA

Aborto Retenido

PERFIL EUNACOM 2.01.2.008

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Aborto Retenido

Definición

Pérdida embrionaria **asintomática** (hallazgo ecográfico). El embarazo murió pero no se expulsó.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Diagnóstico diferencial principal: Embarazo vivo inicial — en etapas muy tempranas puede ser indistinguible del aborto retenido en la ecografía.
La β HCG cuantitativa NO sirve para el diagnóstico de aborto retenido (es útil en ectópico, no aquí).

Criterios Diagnósticos Ecográficos

TABLA 3.10.1: HALLAZGO VS CRITERIO CONFIRMATORIO	
HALLAZGO	CRITERIO CONFIRMATORIO
Saco gestacional sin embrión (huevo anembionado)	Diámetro del saco $\geq$ 25 mm
Embrión sin latidos cardíacos	Longitud del embrión $\geq$ 7 mm
Latidos cardíacos previamente vistos → desaparecen	Confirma independiente del tamaño

Si está bajo los puntos de corte

→ **Control ecográfico en 7-14 días** (puede ser embarazo vivo muy inicial que aún no muestra embrión o latidos por su tamaño)

Manejo

Una vez confirmado el diagnóstico:

TABLA 3.10.2: OPCIÓN VS DETALLE	
OPCIÓN	DETALLE
Observación	Solo < 13 semanas y paciente acepta esperar
Fármacos (misoprostol ± mifepristona)	Más frecuente en práctica
AMEU / Legrado	Si hay complicaciones o paciente prefiere evacuación inmediata

Siempre: - Contención emocional - ROGAM si madre Rh negativo (al momento de evacuar — no si se observa sin evacuar aún) - Biopsia del material evacuado

Casos Prácticos

TABLA 3.10.3: HALLAZGO ECO VS MEDIDA DEL SACO/EMBRIÓN			
HALLAZGO ECO	MEDIDA DEL SACO/EMBRIÓN	DIAGNÓSTICO	CONDUCTA
Saco sin embrión	12 mm	Incierto	Control eco en 7-14 días
Saco sin embrión	28 mm	Aborto retenido	Conducir evacuación
Embrión sin latidos (Doppler)	8 mm	Aborto retenido	Conducir evacuación

| Embrión sin latidos | 5 mm | Incierto | Control eco en 7-14 días |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Respecto a Aborto Retenido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Aborto Retenido. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Definición
- Criterios Diagnósticos Ecográficos
- Si está bajo los puntos de corte
- Manejo
- Casos Prácticos
- (hallazgo ecográfico). El embarazo murió pero no se expulsó.

⚠
- La β HCG cuantitativa NO sirve

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ABORTO RETENIDO)

PREGUNTA 1

Respecto a Aborto Retenido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A) El diagnóstico de Aborto Retenido se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B) El manejo inicial de Aborto Retenido debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C) Todo paciente con Aborto Retenido requiere hospitalización inmediata
- D) El tratamiento de Aborto Retenido es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E) El seguimiento de Aborto Retenido no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Aborto Retenido?

- A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Aborto Retenido. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: ABORTO RETENIDO

:::warning Diagnóstico diferencial principal: Embarazo vivo inicial — en etapas muy tempranas puede ser indistinguible del aborto retenido en la ecografía. La β HCG cuantitativa NO sirve para el diagnóstico de aborto retenido (es útil en ectópico, no aquí). ::: → Control ecográfico en 7–14 días (puede ser embarazo vivo muy inicial que aún no muestra embrión o latidos por su tamaño)